

إسم المريض رابعياً : وفاء حلیم جید سعید

الحى / المدينة : قليوب

المحافظة : القليوبيه

رقم البطاقة : 27401072500829 رقم التلفون : 01223341272

العمر (تاريخ الميلاد) : 07-01-1974 **المهنة :** ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (_____)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدى (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :-----

الاسم:	د/محمد كيلاني	الوظيفة:	التوقيع:
الاسم:	د/ندي حسن	الوظيفة:	التوقيع:
الاسم:	د/نرمين رمضان	الوظيفة:	التوقيع:

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / ۵ ----- / ۵ ----- / ۵. | ----- / ۵. |

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: وفاء حليم جيد سميد National ID: 27401072500829	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



وفاء

حليم جيد سعيد

٢٢ ش محمد نجيب - منطى

قليوب - القليوبية

١٩٧٤/٠١/٠٧

٢٧٤.٠١.٧٢٥.٠٠٨٢٩

LN5744459



٢٠٢٥/١٢ ٢٧٤.٠١.٧٢٥.٠٠٨٢٩

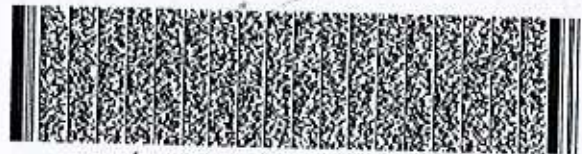
ربة منزل



أنثى مسيحية متزوجة
عاطف عياد جاد السيد عبدالملاك

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/١٢/٢١

١١





 جمهورية مصر العربية
 بطاقة هوية شخصية

وقته
 هادي محمد سعيد
 ٢٢ من شهر الحبيب - ميني
 القلوب - القلوب

٢٧٤٠١٠٧٢٥٠٠٨٢٩
 LN5744459



 ٢٠٢٥/١٢ ٢٧٤٠١٠٧٢٥٠٠٨٢٩
 ربة منزل
 انش
 عاتق عبد جلال عبد الله
 ٢٠٢٢/١٢/٢٩
 البطاقة سارية حتى







Pathology Report

Name: وفاء حليم جريد

Age: 46 years.

Clinical data: Right breast cancer, post chemotherapy.

Specimen type: Right wide local excision & axillary clearance.

Date (received): 6/9/2020

Date (reported): 27/9/2020

Lab. Number: 1349

Hospital Number: 1084/2020

Gross Description:

Wide local excision specimen & axillary clearance enblock measured; 13x11x5 cm, covering skin ellipse; 6.5x3 cm, axillary fat; 11x7 cm.

Cut sections revealed nearly well-defined greyish white mass; 1.5x6.5x3.5 cm, with mucoid cut surface; 1.5 cm, away from skin, just below the deep margin.

Axillary fat dissection revealed 15 nodules, with most of them showing mucoid cut surface, ranging in size from; 0.2 cm up to; 3 cm.

Microscopic Examination and Diagnosis:

Right breast wide local excision & axillary clearance, post chemotherapy;

- Tiny remnants of viable tumor cells & wide mucin areas (acellular mucin).
- Good pathological response to therapy (R1).
- Free skin, and margins
- Free lymph nodes; (0/15).
- Stage; ypT1mi ypN0.

Comment:

Tumor stage calculated according to size of viable invasive tumor cells.

NB: there were 4 lymph nodes showed mucin substance, yet no viable tumor cells.

Prof. Dr. Lubna Omar

Prof. Dr. Gamal Abdel-Aty

Name: *Mahmoud Ged*

Date: *5/2/2020*

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED:-

Known case of breast cancer

1. Chest:

- Right breast soft tissue mass is seen measuring about 5.4 x 7.1 cm with pathologically enlarged right axillary lymph nodes largest measuring about 2.6 x 2 cm.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the dorsal vertebrae.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size with homogenous low CT texture. No focal lesions or biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpocketing.
- Bilateral small ovarian cysts are seen the largest is seen in the right measuring about 1.9 x 1.5 cm.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

OPINION:

- *Known case of breast cancer showing right breast mass with pathologically enlarged right axillary lymph nodes.*
- *No CT evidence of pulmonary or hepatic metastatic disease.*

Dr. Ahmed Rozeky, MSc

Dr. Amr Farouk MD



ImmunohistoChemistry report

Report Number: m158

Female	المرأة	رقم الملف	45 Y
09/01/2020 10:01	تاريخ استلام العينة	في العينة	
15/01/2020 10:55	تاريخ التقرير	معدة المرأة	
		معدة المرأة	

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by : CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody . CONFIRM anti progesterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody .
Sample recieved was treated by : VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.
Sample recieved was treated by : CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER moderate nuclear staining of 70 % of tumour cells
PR NO nuclear staining of tumour cells
HER2/neu protein over expression : discontinuous membrane staining of tumor cells.
Ki67 positive nuclear staining of about 10 % of tumour cells

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER POSITIVE (SCORE 7/8)
PR NEGATIVE
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : NEGATIVE (SCORE 1+)
#Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS ABOUT 10 % .
(CORE BIOPSY)

Pathologist

د. أحمد محمد
أحمد محمد

Lab Director: د. أحمد محمد

18x6 cm

u.o. 4

7.5 cm from m

pathologist

19 El-shekh Rohan Street, Abdeen, Cairo
Tel (165) 7943544 - 7950000 Fax (202) 7943544
Mobile : 01144297292
website <http://www.healthlabs.net>
email pathologych@yahoo.com
facebook [healthlabs](https://www.facebook.com/healthlabs)

* This Test is Not Accredited By EGAC Nor Recognized By I.L.A

هذا الاختبار لم يوافق عليه EGAC ولا يعترف به I.L.A



Patient Name: Wafaa Haleem Gayed Saeed	Date : 16/03/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 51 Year(s)
Medical ID: 1084/2020	Pat. ID: 13884

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had right CBS in

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Still noted left breast UOQ focal asymmetry by US revealed normal glandular condensation
- No left breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Right breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed:
- **Right breast:**
- right breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- Free right infra and supra clavicular regions.
- **Left breast:**
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Single mildly enlarged left axillary LN showing increased cortical thickening reaching 5mm

Opinion:

- Right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Still noted left breast UOQ focal asymmetry likely glandular.
- Single mildly enlarged left axillary LN for close US follow up.

Dr, basma mohmaed